

밤에 종아리에 쥐가 날 때

갑자기 아픈 근육 경련을 푸는 법과 병원에 알려야 할 신호를 알아봅시다.

정말 근육에 쥐가 난 걸까요

50세 이상 약 33%, 60세 이상 약 50%가 겪습니다. 근육이 실제로 뭉치는지 먼저 확인하세요.

【 실제 근육 경련(true cramp)이란

종아리 근육이 갑자기 단단하게 뭉치며 몹시 아픕니다. 보통 수 초~수 분, 드물게 10분 이어집니다. 풀린 뒤에도 48~72시간 누르면 아플 수 있습니다.

👤 병력에서 묻는 세 가지

근육이 실제로 뭉치는지, 늘려 주면 풀리는지, 쉴 때인지 걸을 때인지 기억해 두세요.

실천 · 근육이 굳는지, 걷다가 아픈지 구분해 진료 때 말씀해 주세요.

헛갈리는 것	구별점
근구축(contracture)	겉보기엔 쥐 같지만 근전도가 조용함(전기적 침묵) · 스트레칭으로 안 풀림
근간대경련	0.2초 이내로 짧게 핵 움직임 · 통증 없음
근긴장이상	반대 방향 근육이 함께 수축해 자세가 비틀림
테타니	양쪽 대칭 · Chvostek-Trousseau 징후 양성
하지불안증후군	움직이고 싶은 충동만 · 실제로 뭉치지 않음(국내 유병률 5.4~7.5%)

출처 · 마지막 장

왜 밤에 종아리가 굳을까요

신경이 근육을 갑자기 수축시키는 일이 흔합니다.

말초 운동신경 과흥분

이 경련은 근육에 신호를 보내는 신경 끝에서 시작되는 것으로 보입니다.

근방추·골지건기관 불균형

근육이 짧아진 채 피로가 쌓이면 흥분은 늘고 억제는 줄어듭니다. 스트레칭이 바로 듣는 이유입니다.

TRP 채널 매개 가설

입안 자극이 신경의 과도한 반응을 줄일 수 있다는 설명이 있지만, 아직 연구 단계의 가설입니다.



실천 · 경련이 반복되는 시간과 부위를 적어 두세요.

출처 · 마지막 장

이런 증상은 원인을 확인해야 합니다

걷거나 움직일 때만 아프거나 감각이 달라지면 알려 주세요.



▲ 이럴 땐 원인 검사부터

한쪽 다리에만 반복되거나, 팔·몸통에도 생기거나, 힘이 빠지고 근육이 마르면 진료받으세요. 걸을 때만 아프거나 새 약을 시작한 뒤 생겼다면 꼭 알려 주세요.

🔍 약이 원인일 때

이뇨제 · 베타작용제 · 스타틴 · 니페디핀 · 호르몬제 — 어느 쪽이 먼저인지가 핵심입니다.

🚩 바탕에 다른 병이 있다는 신호

간경변 · 만성콩팥병 · 투석 · 갑상선 · 당뇨 신경병증 · 임신 · 몸속 소금 성분 이상.

실천 · 붓기·한쪽 다리 통증·감각 이상이 함께 있으면 진료받으세요. 숨이 차거나 가슴이 아프면 바로 응급실로 가세요.

출처 · 마지막 장

복용 중인 약도 확인하세요

새로 시작한 약과 건강 상태를 함께 살펴봅니다.



확인하는 순서

최근 3개월에 새로 시작하거나 용량을 올린 약이 있나요?
경련보다 먼저였는지 확인하고, 조정은 처방 의사와
상의하세요.



약을 더하기 전에

경련약을 더 먹기 전에 현재 복용약이 원인인지 함께
살펴봅니다. 스스로 약을 끊지는 마세요.

약	어떻게 경련을 부르나	확인할 것
이뇨제	칼륨·마그네슘 저하	몸속 소금 성분 · 시작 시점과 증상 시점
흡입 β 작용제	몸속 소금 성분을 흔듦	시작·증량 시점과 비교
위산억제제(PPI) 장기	마그네슘 저하	마그네슘 · 계속 필요한지
스타틴	근육에 직접	근육효소(CK) 확인 후 감량·변경 검토
니페디핀 · 칼록시펜· 에스트로겐 · 정맥 철분제	보고된 약	시작 시점과 비교 · 바꿀 수 있는지

실천 · 약 봉투를 가져오고 약은 스스로 끊지 마세요.

출처 · 마지막 장

검사는 증상에 맞춰 고릅니다

전형적인 경련은 먼저 이야기와 진찰로 평가합니다.

1. 기본

다른 원인이 의심되면

단서가 있으면 나트륨·칼륨·칼슘(알부민 보정)·마그네슘, 혈당/당화혈색소, 콩팥·간·갑상선(TSH) 수치를 봅니다. 근육통이 있으면 근육효소(CK)도 봅니다.



2. 상황별

의심될 때 추가

술·영양결핍 → 인(P) · 하지불안증후군 구별 → 페리틴 · 신경병증 의심 → 비타민 B12.



3. 의뢰

큰 병원으로

힘 빠짐·근육 마름·실룩거림 → 신경검사. 걸을 때 통증·발 맥박 약함 → 발목-팔 혈압비(ABI). 다리로 뻗는 통증 → 허리 MRI.



다른 원인이 없다면

진찰과 필요한 검사에서 다른 원인이 보이지 않으면 흔한 야간 근육 경련으로 봅니다.

실천 · 검사 전에 증상이 생기는 상황을 자세히 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

먼저 종아리를 늘려 주세요

쥐가 나면 발끝을 몸 쪽으로 천천히 당깁니다.

자기 전 종아리·허벅지 뒤 스트레칭

고령자 비교 연구에서는 자기 전 종아리 스트레칭이 경련 횟수와 강도를 줄였습니다.

실제로 하는 방법

벽을 짚고 뒷다리 무릎을 펴서 종아리를 10초씩 3회 늘려 주세요. 자기 전에 매일 해 보세요.

다시 평가하는 때

스트레칭을 6주 해 본 뒤 다시 평가합니다. 잠자리 자세, 수분, 카페인과 술도 함께 살펴보세요.



실천 · 쥐가 나면 무릎을 펴고 발끝을 몸 쪽으로 천천히 당기세요.

출처 · 마지막 장

잠자는 자세도 살펴보세요

발끝이 오래 아래로 향하지 않게 이불과 자세를 조절합니다.



⚠ 무엇이 문제인가

이불 무게로 발끝이 **밤새 아래로** 향하면 종아리가 짧아진 채 피로가 쌓입니다.

📖 바꿀 것

발치 쪽 이불을 느슨하게 해 발등이 눌리지 않게 합니다. 필요하면 베개로 발목을 **바로 세워** 받칩니다.

🧑 같이 바꿀 것

수분 · 카페인·술 줄이기 · 활동량 유지(너무 적어도, 갑자기 늘려도 경련이 옵니다).

실천 · 이불이 발끝을 누르는지 오늘 밤 확인해 보세요.

출처 · 마지막 장

마그네슘과 경련약, 무엇을 알까요

마그네슘의 효과는 확인되지 않았고 일부 약은 위험할 수 있습니다.

🔍 마그네슘 — 근거는 음성

다른 원인이 없는 야간 경련에는 마그네슘이 가짜약보다 낫다고 입증되지 않았습니다. 임신·검사로 확인된 부족·이뇨제 또는 위산 억제제 장기 복용은 따로 상의하세요.

⚠️ 퀴닌 — 쓰지 않습니다

퀴닌은 경련을 줄일 수 있지만 피를 멎게 하는 혈소판이 줄거나 심장 박동에 문제가 생길 수 있어 여러 나라에서 사용을 제한합니다.

약	근거	판단
딜티아젬	규모가 작은 무작위 시험의 긍정적 신호 PMID 11322688	권고하기엔 이릅니다
비타민 B 복합	소규모 무작위 시험 PMID 11301568	보조적으로만
타우린	간경변 환자 경련 무작위 대조시험 PMID 30136291	간경변일 때(다음 장)

실천 · 마그네슘이나 경련약을 임의로 시작하지 마세요.

출처 · 마지막 장

쥐가 난 순간 이렇게 해 보세요

잠결에도 할 수 있도록 진료실에서 한 번 연습해 보세요.



01

손으로 눌러 펴기

쥐가 나면 무릎을 펴고 발끝을 몸 쪽으로 당겨 종아리를 늘리세요. 풀린 뒤에는 마사지나 온찜질을 할 수 있습니다.

가장 먼저 할 일



02

피클 주스 반사 억제

실험에서는 피클 주스를 조금 마셨을 때 경련이 잦아졌지만, 실제 밤 경련 치료로 확인된 방법은 아닙니다.

야간 경련 효과는 미확인



03

풀린 뒤에 알아 둘 것

경련이 풀린 뒤 2~3일은 누르면 아플 수 있습니다. 2주 동안 언제, 얼마나 자주 생기는지 적어 보세요.

2주 일지 → 다시 진료

실천 · 잠결에 넘어지지 않도록 앉은 자세에서 먼저 눌러 주세요.

출처 · 마지막 장

임신·간질환·투석 중이라면

몸 상태에 따라 일반적인 대처와 다른 치료가 필요할 수 있습니다.

간경변

삶의 질을 가장 크게 떨어뜨립니다

간경변이 있다면 진료 때 경련을 먼저 말씀해 주세요. 타우린을 살핀 연구가 있지만 치료는 담당 의사가 정합니다.

혈액투석

투석 처방 조정이 원인에 더 가깝습니다

투석 중이라면 투석 처방부터 확인합니다. 비타민 E와 가바펜틴을 살핀 연구도 있지만 스스로 시작하지 마세요.

임신

중기 이후 혼합니다

임신 중이라면 먼저 종아리 스트레칭처럼 약을 쓰지 않는 방법을 해 보세요. 퀴닌은 쓰지 않습니다.

실천 · 임신·간질환·투석 중이면 먼저 담당 의사와 상의하세요.

출처 · 마지막 장

진료실에서 함께 정할 순서

원인 확인, 스트레칭, 재평가 순서로 함께 결정합니다.

① 구별

실제 근육 경련인가

근육이 단단하게 뭉치고, 눌리면 풀리며, 수 초~수 분 이어졌는지 알려 주세요.



② 위험신호

네 축 훑기

혈관·신경·몸속 수치·복용약을 살피고, 필요한 검사만 고릅니다.



③ 1차 처방

자기 전 스트레칭

자기 전 종아리 스트레칭을 10초씩 3회, 매일 해 보고 6주 뒤 다시 평가합니다.



④ 약물

좁고 신중하게

퀴닌은 사용하지 않습니다.
마그네슘은 부족이 의심될 때만 담당 의사와 상의하세요.



대부분은 여기서 끝납니다

대부분은 원인 설명과 스트레칭으로 관리합니다. 간경변·투석·임신 중이라면 별도로 상의하세요.

실천 · 스트레칭을 해도 반복되면 다시 진료받으세요.

출처 · 마지막 장

다시 보기 · 문의

QR로 같은 자료를 다시 열 수 있습니다.

광고바른내과

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

밤에 종아리에 쥐가 나는 분을 위한 설명자료입니다. 약을 시작하거나 바꿀 때는 담당 의사와 상의하세요.

참고한 자료

참고: 야간 경련 지침 · 스트레칭 PMID 22341378 · 마그네슘 32956536, 28241153 · 퀴닌 25842375 ·
타우린 30136291, 33381931 · 기타 28192854, 19997012, 19829096, 26586051



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다